



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я



ТИЖНЕВИЙ ЗВІТ ПРО РИЗИКИ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я

34 ТИЖДЕНЬ 2025 РОКУ
(18–24 СЕРПНЯ)

КЛЮЧОВІ РИЗИКИ

Воєнний стан, функціональна підсистема медичного захисту

Із 24 лютого 2022 року в країні Указом Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102, запроваджено воєнний стан, дію якого продовжено Указами Президента від 14.03.2022 № 133 (затверджено Законом України від 15.03.2022 № 2119-IX), від 18.04.2022 № 259/2022 (затверджено Законом України від 21.04.2022 № 2212-IX), від 17.05.2022 № 341/2022 (затверджено Законом України від 22.05.2022 № 2263-IX), від 12.08.2022 № 573/2022 (затверджено Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX), від 07.11.2022 № 757/2022 (затверджено Законом України від 08.11.2022 № 8189-IX), від 06.02.2023 № 58/2023 (затверджено Законом України від 07.02.2023 № 2916-IX), від 01.05.2023 № 254/2023 (затверджено Законом України від 02.05.2023 № 9259-IX), від 26.07.2023 № 451/2023 (затверджено Законом України від 27.07.2023 № 9532-IX), від 06.11.2023 № 734/2023 (затверджено Законом України від 08.11.2023 № 3429-IX), від 05.02.2024 № 271/2024 (затверджено Законом України від 06.02.2024 № 10456-IX), від 06.05.2024 № 49/2024 (затверджено Законом України від 08.05.2024 № 3684-IX), від 23.07.2024 № 469/2024 (затверджено Законом України від 07.08.2024 № 3891-IX), від 28.10.2024 № 740/2024 (затверджено Законом України від 29.10.2024 № 12151-IX), від 14.01.2025 № 26/2025 (затверджено Законом України від 15.01.2025 № 12404-IX), від 15.04.2025 № 235/2025 (затверджено Законом України від 16.04.2025 № 4356-IX) та від 14.07.2025 № 478/2025 (затверджено Законом України від 15.07.2025 № 4524-IX) — із 7 серпня 2025 року на 90 діб.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 № 179-р єдину державну систему цивільного захисту приведено у готовність до виконання завдань за призначенням в умовах воєнного стану та розпочато впровадження Плану цивільного захисту України на особливий період.

18 серпня 2025 року презентовано Проєкт Програми дій Уряду: ключові пріоритети у сфері охорони здоров'я: <https://www.kmu.gov.ua/news/prezentovano-proekt-prohramy-dii-uriadu-kliuchovi-priorytety-u-sferi-okhorony-zdorovia>

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до впровадження міжнародних медико-санітарних правил — міжнародного документа, який визначає, як країни світу мають реагувати на загрози здоров'ю людей під час перетину державного кордону. Йдеться про спалахи інфекцій, отруєння, радіаційні чи хімічні загрози. Таким чином, Україна посилює захист населення від загроз здоров'ю на кордонах, інтегрується в європейську систему громадського здоров'я та виконує свої міжнародні зобов'язання. А завдяки залученню фахівців ЦКПХ та оновленому порядку взаємодії, реагування на потенційні загрози стане швидшим, прозорішим та більш скоординованим: <https://www.kmu.gov.ua/news/zminy-do-mizhnarodnykh-medyko-sanitarnykh-pravyl-ukraina-vprovadzhuie-standarty-ies-ta-posyliuie-kontrol-na-kordonakh>

Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію наркополітики до 2030 року та затвердив операційний план з її реалізації на 2025 – 2027 роки. Державна політика у сфері наркотиків сприятиме зменшенню вживання психоактивних речовин і протидії їх незаконному обігу: <https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-ukhvalyv-derzhavnu-stratehiu-narkopolityky-do-2030-roku-ta-zatverdyy-operatsiyniy-plan-z-ii-realizatsii>

МОЗ спільно з Бюро ВООЗ в Україні, Європейським регіональним бюро ВООЗ та міжнародними партнерами провели повномасштабне симуляційне навчання (SimEx) в Одесі. Сценарій навчання імітував спалах інфекційної хвороби в розпал туристичного сезону, ускладнений пошкодженнями інфраструктури після обстрілів. Отримані результати враховуватимуть для вдосконалення національних і регіональних планів та алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації у сфері громадського здоров'я: <https://moz.gov.ua/uk/v-odesi-vidbulosya-simulyacijne-navchannya-z-gotovnosti-medichnih-komand-do-jmovirnih-spalahiv-hvorob-sho-peredayutsya-cherez-vodu>

Кір (гостра вірусна інфекція)

Спалахи кору — циклічні та повторюються приблизно раз на п'ять років; зараз ризик спалаху оцінюють як високий. Востаннє спалах кору в Україні був у 2017–2019 роках. Тоді померла 41 людина (зокрема 25 дітей). Причина — низький рівень охоплення щепленнями.

У 2024 році в Україні зареєстрували 433 випадки кору, що майже всемеро більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року (65 випадків). Більшість випадків зареєстровано серед дітей до 17 років — 365 випадків (84,2 %). Летальних випадків не зафіксовано. Не були вакциновані або не мали даних про щеплення 245 хворих (56,6%), зокрема 150 дітей (61,2%).

За 7 місяців 2025 року в Україні зареєстровано 1 377 випадків кору, що майже у 9 разів більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року (152 випадки). Більшість випадків зареєстровано серед дітей до 17 років — 1 017 випадків (73,7 %), відмічається зростання у 8,8 разів (115 випадків у 2024 році). Дорослі становлять 26,3% випадків захворювання (360 проти 37).

Не були вакциновані або не мали даних про щеплення 808 хворих (58,6%).

Зареєстровано 2 летальні випадки: у нещепленої 10-річної дитини із Чернівецької області; у одноразово щепленої 9-місячної дівчинки із спеціалізованого будинку дитини Одеської області.

Випадки кору реєструвалися у 20 регіонах країни: Івано-Франківська (416), Чернівецька (338), Вінницька (213), Закарпатська (162), Одеська (49), Хмельницька (35), Львівська (35), Дніпропетровська (23), Полтавська (9), Миколаївська (8), Київська (6), Тернопільська (4), Волинська (3), Харківська (3), Донецька (2), Черкаська (2), Запорізька (1), Житомирська (1), Чернігівська (1) області та м. Київ (66).

Станом на 25 серпня 2025 року в Україні було зареєстровано 65 спалахів кору у 11 областях та м. Київ: у Одеській (5 спалахів: 2 - у медичних закладах; 3 - у домашньому вогнищі); у Вінницькій (27 спалахів: 1 - у міській клінічній лікарні; 1 - у будинку дитини; 1 - у медичному університеті, 2 - у фаховому коледжі; 1 - у дитячому відділенні психоневрологічної лікарні, 1 - у ліцеї, 20 - у домашньому вогнищі); у Дніпропетровській (2 спалахи; 1 - у медичному університеті; 1 - у домашньому вогнищі); у Донецькій (1 спалах серед працівників державного органу спеціального призначення), у Львівській (6 спалахів у домашньому вогнищі), у Чернівецькій (6 спалахів: 1 - у медичному закладі, 1 - на підприємстві-об'єкт критичної інфраструктури, 2 - серед дітей дитячого дошкільного закладу, 2 - серед учнів ліцею); у Івано-Франківській (9 спалахів: 1 - у дитячій дошкільній установі, 3 - у фахових коледжах та ліцеях; 1 - у Центрі надання адміністративних послуг; 4 - у домашньому вогнищі); у Миколаївській (2 спалахи у домашньому вогнищі); у Закарпатській (1 спалах у домашньому вогнищі); у Полтавській (1 спалах у домашньому вогнищі); у Хмельницькій (1 спалах у дитячій лікарні) та м. Київ (4 спалахи: 2 - серед учнів школи; 2 - у домашньому вогнищі).

З 2026 року будуть впроваджені зміни до Календаря профілактичних щеплень. А саме вакцинація від кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК) проводитиметься в 1 та 4 роки — замість 1 та 6 років, як зараз: <https://moz.gov.ua/uk/onovlennya-algoritmu-dij-z-protidiiyi-poshirenniya-koru-ta-posilennya-rutinnoyi-vakcinaciyi-po-krayini-fahivci-moz-vooz-ta-cgz-proveli-koordinacijnu-naradu-z-regionami>

Стаття 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» регламентує, що невакциновані діти не можуть відвідувати виховні, навчальні, оздоровчі та інші дитячі заклади, за винятком тих осіб, які мають медичні протипоказання до вакцинації. Обмеження на відвідування дитячих закладів необхідні для гарантування безпечного середовища у школах чи дитсадках з огляду на високий ризик спалаху кору в Україні: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14>.

Сезонний грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), зокрема COVID-19 (ГРХ, спричинена (SARS-CoV-2)

За підсумками 15-го засідання Комітету ВООЗ із ММСП (2005), що відбулося 4 травня 2023 року, пандемія COVID-19 більше не є надзвичайною ситуацією міжнародного значення для громадського здоров'я.

Станом на ранок 25 серпня 2025 року у світі було зареєстровано 778 474 217 випадків захворювання на COVID-19 (більше 111,82 млн — у США та понад 99,38 млн — в Китаї), зокрема 7 099 716 летальних. На території Європи зафіксовано 281 322 281 підтверджений випадок інфекції: лідирують Франція — 40 138 560 (померли 168 162), Німеччина — 38 828 995 (183 027), Італія — 26 968 605 (199 600).

Як і минулого року в Україні фіксується зростання захворюваності на COVID-19 у серпні. Однак цього року кількість захворілих менша на 65%: з початку серпня 2025 року зареєстровано 8 714 випадків COVID-19 (1 342 пацієнти отримали лікування у стаціонарі), у серпні 2024 року було 26 451 випадок (лікування у стаціонарі отримало 3 191 пацієнт).

Наразі найбільше захворілих зареєстровано у Києві (2 076) та області (726), Дніпропетровській (1 469) та Львівській (735) областях.

З початку 2025 року змінилися глобальні тенденції щодо варіантів SARS-CoV-2. За класифікацією ВООЗ наразі до категорії «варте уваги» (VOI) віднесено єдину підлінію Omicron: JN.1 (Jenny); також 6 варіантів під моніторингом (VUM), а саме NB.1.8.1 (Nimbus), LP.8.1, XFG (Stratus), XEC, KP.3.1.1 та KP.3.

В Україні підтверджено 81 випадок субваріанта «Stratus» (у 7 областях). 2 випадки — «Nimbus» (по одному на Одещині і на Вінниччині): <https://moz.gov.ua/uk/v-ukrayini-sposterigayetsya-zrostannya-kilkosti-hvorih-na-kovid-odnak-zahvoryuvanist-u-tri-razi-nizhcha-nizh-u-serpni-minulogo-roku>

Захворіти можуть і раніше вакциновані, однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби. Інформацію про найближчі пункти вакцинації, їхні адреси та графік роботи можна запитати в операторів контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Радіаційний (гамма) фон

На ранок 25.08.2025 радіаційні показники були в межах природного фону, характерних для зазначених територій. Дані про радіаційний стан на промислових майданчиках і в зонах спостереження інших атомних станцій АТ «НАЕК «Енергоатом»: <https://old.energoatom.com.ua/table.html>.

Постійна присутність Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) триває майже три роки, і вона залишається критично важливою для зменшення ризику ядерної аварії під час війни.

Протягом минулого тижня команда МАГАТЕ фіксувала регулярні ознаки військової активності поблизу Запорізької АЕС, а також інших українських атомних станцій. 21 серпня 2025 року команда МАГАТЕ, що працює на Чорнобильській АЕС, була розбуджена звуками численних вибухів. Було зафіксовано кілька безпілотних літальних апаратів, а вибухи були наслідком зенітного вогню.

Усі шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодної зупинки з весни 2024 року, проте все ще потребують охолоджувальної води для систем безпеки, активних зон реакторів та басейнів витримки відпрацьованого палива. Додатково була зведена дамба з метою утримання води у каналі, що забезпечує охолодження інших систем, необхідних для підтримання станції у безпечному режимі зупинки впродовж тривалого часу.

ЗАЕС вже понад три місяці підключена до однієї зовнішньої лінії електропередач. Це найдовший період часу, коли на майданчику не було резервної лінії електропередач.

Ризики для ядерної безпеки України залишаються значними, особливо у зв'язку з охолодженням реакторів і стабільністю енергопостачання: <https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-310-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine>

Докладніше про COVID-19 — у розділі «Повідомлення ММСП» і на веб-сайті ВООЗ: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>; про зміни у законодавстві України внаслідок воєнного стану — у розділі «Сигнальні показники».

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ГРИП ТА ГРВІ В УКРАЇНІ

Докладніше про захворюваність на грип та ГРВІ в Україні:
<https://phcorgua.sharepoint.com/sites/communication/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fcommunication%2FShared%20Documents%2F%2Boperinfo%5FGRYP&p=true&ga=1>

СПАЛАХИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

За звітний тиждень в Україні було зареєстровано 5 спалахів: 2 – гострих кишкових інфекцій, 2 – сальмонельозу та 1 – ентеровірусної інфекції.

Інфекційна хвороба	Кількість спалахів	Область/місто	Кількість постраждалих	Ймовірна причина
ГКІ	2	Дніпропетровська область Синельниківський район, м. Шахтарське	3	За даними епідрозслідування, захворіли 3-є дітей, мешканці м.Шахтарське Синельниківського району Дніпропетровської області. Встановлено, що захворілі діти є членами однієї родини і мешкають в одному з реабілітаційних центрів у м. Шахтарське Синельниківського району Дніпропетровської області. Лабораторно обстежено 4 декретованих та контактних осіб Епідрозслідування, лабораторні дослідження та протиепідемічні заходи тривають.
		Львівська область, Стрийський район, с. Славське	18	За даними епідрозслідування, захворіли 18 людей, з них 16 дітей, мешканці Дніпропетровської Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Рівненської, Харківської та Черкаської областей. Встановлено, що захворілі діти перебували на відпочинку в одному із готельно-відпочинкових комплексів у с.Славське Стрийського району Львівської області, дорослі - здійснювали супровід. Харчування організоване в ресторані закладу. Лабораторно обстежено 3-х декретованих осіб. Епідрозслідування, лабораторні дослідження та протиепідемічні заходи тривають.
Сальмонельоз	2	Дніпропетровська область, Дніпровський район с. Дослідне	14	За даними епідрозслідування, захворіли 14 людей, з них 1 дитина, мешканці Дніпропетровської області. Встановлено, що захворілі вживали «Шаурму з курячим м'ясом» придбану в одному із закладів громадського харчування в с.Дослідне Дніпровського району Дніпропетровської області. У всіх хворих діагноз підтверджено лабораторно. Лабораторно обстежено 2 декретовані особи.

				Епідрозслідування, лабораторні дослідження та протиепідемічні заходи тривають.
		Миколаївська область, м.Вознесенськ	8	За даними епідрозслідування, захворіли 8 людей, з них 6 дітей, мешканці Вознесенського району Миколаївської області. Встановлено, що захворіли в складі групи прибули з відпочинку. Перебували в одному із санаторіїв в с. Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області. У 6 хворих діагноз підтверджено лабораторно. Лабораторно обстежено 15 декретованих та контактних особи. Епідрозслідування, лабораторні дослідження та протиепідемічні заходи тривають.
Ентеровірусна інфекція	1	Київська область, Білоцерківський район, с. Глушки	6	За даними епідрозслідування, захворіли 6 дітей, мешканці с.Глушки Білоцерківського району Київської області. Встановлено, що захворіли діти є членами однієї родини. Лабораторно обстежено 1 контактну особу. Епідрозслідування, лабораторні дослідження та протиепідемічні заходи тривають.

ІНШІ СИТУАЦІЇ

- За звітний тиждень було зареєстровано осередки ботулізму, отруєння дикорослими грибами та чадним газом.
- 2 осередки ботулізму, внаслідок яких постраждали 1 дорослий і 1 дитина:
 - у Волинській області — 1 осередок, внаслідок якого постраждала 1 дитина (ймовірна причина — не встановлена). Протиботулінічну сироватку введено.
 - у Кіровоградській області — 1 осередок, внаслідок якого постраждав 1 дорослий (ймовірна причина — тушонка домашнього виробництва). Протиботулінічну сироватку не введено.
- 1 осередок отруєння дикорослими грибами у Івано-Франківській області, внаслідок якого постраждала 1 дитина (ймовірна причина – сирожки).
- За результатами огляду інтернет-повідомлень зареєстровано осередок отруєння чадним газом у Львівській області(постраждали 2 дорослих та 1 дитина), .

ІНШІ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

Завізний випадок малярії в Одеській області

В Одеській області було зареєстровано завізний випадок малярії у громадянина Туреччини.

Захворів чоловік, 26 років, громадянин Туреччини, постійно мешкає в м. Одеса, оформлює громадянство України, працює другим помічником капітана.

За даними епідеміологічного анамнезу відомо, що чоловік перебував в рейсі - з 27 березня по 13 серпня 2025 року, судно під прапором Ліберії перебувало під вантажними операціями. Під час стоянки судна в порту Тінкан (Нігерія) хворий відвідував місто. Зі слів, під час міжнародного рейсу при перебуванні в країнах Африки, ендемічних з малярії, він отримував медичний препарат для проведення хіміопрофілактики малярії.

Вважає себе хворим з 01.08.2025 року, коли з'явилися скарги на підвищення температури тіла до 38,7°C, озноб, слабкість, головокружіння, ломоту в тілі.

02.08.2025р в Нігерії звернувся до берегової медичної установи, де після обстеження хворому підтвердили діагноз: «Малярія» та призначили специфічне лікування.

Чоловік прибув до України 15.08.2025р. повітряним транспортом за маршрутом аеропорти Стамбул-Кишинів, автобусом Кишинів - Одеса.

19.08.2025р. повторно з'явилися скарги на підвищення температури тіла до 38,7°C та озноб. 20.08.2025р. самостійно звернувся до приймального відділення однієї з міських інфекційних лікарень та був госпіталізований з діагнозом «Малярія?»

За результатом лабораторного дослідження крові у хворого було виявлено збудники малярії.

Діагноз «Малярія» підтверджено лабораторно.

Хворий отримує все необхідне специфічне та симптоматичне лікування.

Здійснюється епідеміологічне обстеження осередку та запроваджено комплекс протиепідемічних заходів.

СИГНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ

Із 24 лютого 2022 року в країні Указом Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102, запроваджено воєнний стан, дію якого продовжено Указами Президента від 14.03.2022 № 133 (затверджено Законом України від 15.03.2022 № 2119-IX), від 18.04.2022 № 259/2022 (затверджено Законом України від 21.04.2022 № 2212-IX), від 17.05.2022 № 341/2022 (затверджено Законом України від 22.05.2022 № 2263-IX), від 12.08.2022 № 573/2022 (затверджено Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX), від 07.11.2022 № 757/2022 (затверджено Законом України від 08.11.2022 № 8189-IX), від 06.02.2023 № 58/2023 (затверджено Законом України від 07.02.2023 № 2916-IX), від 01.05.2023 № 254/2023 (затверджено Законом України від 02.05.2023 № 9259-IX), від 26.07.2023 № 451/2023 (затверджено Законом України від 27.07.2023 № 9532-IX), від 06.11.2023 № 734/2023 (затверджено Законом України від 08.11.2023 № 3429-IX), від 05.02.2024 № 271/2024 (затверджено Законом України від 06.02.2024 № 10456-IX), від 06.05.2024 № 49/2024 (затверджено Законом України від 08.05.2024 № 3684-IX), від 23.07.2024 № 469/2024 (затверджено Законом України від 07.08.2024 № 3891-IX), від 28.10.2024 № 740/2024 (затверджено Законом України від 29.10.2024 № 12151-IX), від 15.04.2025 № 235/2025 (затверджено Законом України від 16.04.2025 № 4356-IX) та від 14.07.2025 № 478/2025 (затверджено Законом України від 15.07.2025 № 4524-IX) — із 7 серпня 2025 року на 90 діб.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 № 179-р єдину державну систему цивільного захисту приведено у готовність до виконання завдань за призначенням в умовах воєнного стану та розпочато впровадження Плану цивільного захисту України на особливий період.

18 серпня 2025 року презентовано Проєкт Програми дій Уряду: ключові пріоритети у сфері охорони здоров'я: <https://www.kmu.gov.ua/news/prezentovano-proekt-prohramy-dii-uriadu-kliuchovi-priorytety-u-sferi-okhorony-zdorovia>

Перелік наказів, ухвалених під час воєнного стану: <https://moz.gov.ua/informacija-dlijamedikiv>.

- Наказом МОЗ від 06.12.2022 № 2213 затверджено Положення про функціональну підсистему забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення єдиної державної системи цивільного захисту: https://ips.ligazakon.net/document/view/re38937?an=123&ed=2022_12_06.

- Наказом МОЗ від 11.01.2023 № 53 визначено структурний підрозділ МОЗ, який забезпечує реалізацію пріоритетних напрямів інформатизації галузевої інформаційно-комунікаційної системи МОЗ України «HealthNet»: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1614-22#Text>.

- Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.02.2023 № 354 затверджено Санітарно-протиепідемічні вимоги до новозбудованих, реставрованих і реконструйованих закладів охорони здоров'я та Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я: https://ips.ligazakon.net/document/view/re39618?an=1&ed=2023_02_21
- Наказом Міністерства охорони здоров'я від 22.02.2023 № 364 утворено Робочу групу з питань розробки проекту змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»: https://moz.gov.ua/uploads/8/44153-dn_364_22022023.pdf.
- Наказом МОЗ України від 02.06.2023 № 1005 затверджено розподіл функціональних ліжок для потреб охорони здоров'я: https://moz.gov.ua/uploads/9/46894-dn_1005_02062023.pdf.
- Наказом МОЗ України від 21.07.2023 № 1332 утворено та затверджено склад Національної технічної групи експертів з питань імунoproфілактики: <https://ips.ligazakon.net/document/MOZ34675>.
- Наказом МОЗ від 23.08.2023 № 1513 затверджено новий стандарт медичної допомоги «Рациональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою»: https://moz.gov.ua/uploads/9/49093-dn_1513_23082023.pdf.
- Наказом МОЗ від 21.12.2023 № 2172 затверджено План реагування на надзвичайні ситуації МОЗ у сфері медичного захисту населення та санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: <https://ips.ligazakon.net/document/MOZ35176>.
- Наказом МОЗ від 21.02.2024 № 299 затверджено Розподіл обов'язків між Міністром охорони здоров'я України, першим заступником Міністра, заступниками Міністра та Державним секретарем Міністерства і Порядок взаємозаміщення Міністра охорони здоров'я України та заступників Міністра на час їхньої тимчасової відсутності: https://moz.gov.ua/uploads/10/53768dn_299_21022024.pdf.
- Наказом МОЗ України від 23.08.2024 № 1481 затверджено примірної структури центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України: <https://moz.gov.ua/uk/decrees/nakaz-moz-ukrayini-vid-23-08-2024-1481-pro-zatverdzhennya-primirnoyi-strukturi-centru-kontrolyu-ta-profilaktiki-hvorob-ministerstva-ohoroni-zdorov-ya-ukrayini>
- Наказом МОЗ України від 09.10.2024 № 1724 затверджено Перелік особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v172428224#Text>.
- Наказом МОЗ України від 27.01.2025 № 166 затверджено Перелік відповідальних щодо виконання завдань, передбачених Цілями сталого розвитку в Україні на період до 2030 року: <https://moz.gov.ua/uk/decrees/nakaz-moz-ukrayini-vid-27-01-2025-166-pro-vikonannya-zavdanperedbachenih-cilyami-stalogo-rozvitku-v-ukrayini-na-period-do-2030-roku>
- Наказом МОЗ України від 26.03.2025 № 540 внесено зміни до Положення про Департамент медичних послуг Міністерства охорони здоров'я України: <https://moz.gov.ua/uk/decrees/nakaz-mozukrayini-vid-26-03-2025-540-pro-vnesennya-zmin-dopolozhennya-pro-departament-medichnih-poslugministerstva-ohoroni-zdorov-ya-ukrayini>
- Наказом МОЗ України від 26.03.2025 № 543 внесено зміни до методичних рекомендацій з планування та розрахунку потреби в лікарських засобах, продуктах спеціального харчування та виробів медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів: <https://moz.gov.ua/uk/decrees/nakaz-moz-ukrayini-vid-26-03-2025-543-provnesennyzmindometodichnih-rekomendacij-z-planuvannya-ta-rozrahunku-potrebi-v-likarskihzasobahproduktahspecialnogo-harchuvannya-ta-virobah>
- Наказом МОЗ України від 15.04.2025 № 646 внесено зміни в Примірне положення про утворення та діяльність консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при Міністерстві охорони здоров'я України: <https://moz.gov.ua/uk/decrees/nakaz-moz-ukrayini-vid-15-04-2025-646-pro-vnesennya-zmin-v-primirne-polozhennya-pro-utvorennya-ta-diyalnist-konsultativnih-doradchih-ta-inshih-dopomizhnih-organiv-pri-ministerstvi-ohoroni-zdorov-ya-ukrayini>
- Наказом МОЗ України від 23.04.2025 № 703 затверджено Операційний план переходу України на Міжнародну статистичну класифікацію хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я

одинадцятого перегляду на 2025-2026 роки: <https://moz.gov.ua/uk/decrees/nakaz-moz-ukrayini-vid-23-04-2025-703-pro-zatverdzhennya-operacijnogo-planu-perehodu-ukrayini-na-mizhnarodnu-statistichnu-klasifikaciju-hvorob-ta-sporidnenih-problem-ohoroni-zdorov-ya-odinadcyatogo-pereglyadu-na-2025-2026-roki>

- Наказом МОЗ України від 05.06.2025 № 945 затверджено Плани основних заходів цивільного захисту функціональних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту у сфері охорони здоров'я на 2025 рік: <https://moz.gov.ua/uk/decrees/nakaz-moz-ukrayini-vid-05-06-2025-945-pro-zatverdzhennya-planiv-osnovnih-zahodiv-civilnogo-zahistu-funkcionalnih-pidsistem-yedinoyi-derzhavnoyi-sistemi-civilnogo-zahistu-u-sferi-ohoroni-zdorov-ya-na-2025-rik>

Офіційна інформація щодо заходів цивільного захисту та проти коронавірусної хвороби в Україні: <https://moz.gov.ua/novini>, <https://www.phc.org.ua>.

ПОВІДОМЛЕННЯ ММСП

Отримано повідомлення з інформаційного сайту ВООЗ щодо подій для національних координаторів з питань ММСП (WHO Event Information Site for IHR National Focal Points).

ВООЗ про моніторинг випадків захворювання, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, у світі станом на ранок 25 серпня 2025 року

Оскільки багато країн припинили звітування про COVID-19 та інтегрують його в епіднагляд за респіраторними захворюваннями, ВООЗ використовує всі доступні джерела для продовження моніторингу епідеміологічної ситуації з COVID-19, зокрема дані про захворювання та вплив на системи охорони здоров'я: <https://data.who.int/dashboards/covid19/summary>.

Протягом моніторингового періоду з 7 липня 2025 року по 3 серпня 2025 року тільки 35,4% (83 із 234) країн у п'яти регіонах ВООЗ повідомили про нові випадки COVID-19, а про випадки смерті від наслідків захворювання — 17,9% (42 із 234).

Протягом моніторингового періоду було зареєстровано 56 174 нові випадки, зменшення понад в 3 рази порівняно з 184 020 випадків, зареєстрованими у 92 країнах за попередній моніторинговий період. Загалом, 28 країн з Америки, Європи та Південно-Східної Азії продемонстрували зростання кількості нових випадків понад 10%.

Протягом моніторингового періоду було зареєстровано 885 нових смертей, зменшення на 22% порівняно з 1 132 смертями, зареєстрованими у 42 країнах за попередній моніторинговий період. Десять країн з Америки, Європи та Південно-Східної Азії повідомили про збільшення (понад 10%) кількості нових смертей. У червні 2025 року 87% зареєстрованих смертей з інформацією про вік сталися серед населення віком 65 років і старше.

Станом на 25 серпня 2025 року за даними ВООЗ у світі було зафіксовано 778 474 217 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, зокрема 7 099 716 летальних. Найбільше випадків захворювання підтверджено у США — 111 820 082 (померли 1 225 927), Китаї — 99 381 761 (122 398), Індії — 45 055 912 (533 834), Франції — 40 138 560 (168 162), Німеччині — 38 828 995 (183 027).

Протягом моніторингового періоду активність SARS-CoV-2 була загалом низькою, моніторинг стічних вод у Європі та Північній Америці не вказує на зростання активності вірусу.

Variant	Prevalence ▼	Category	Change
XFG	54.43%	VUM	+3.04
NB.1.8.1	29.97%	VUM	+1.18
LP.8.1	7.03%	VUM	-4.14
JN.1	4.13%	VOI	+1.11
Others	3.06%	Others	-3.96
KP.3.1.1	0.61%	VUM	-0.29
XEC	0.61%	VUM	-0.12
KP.3	0.15%	VUM	-0.34

■ VOI: Variant of Interest
 ■ VUM: Variant under Monitoring
 ■ Others: Other variants

Циркуляція варіантів SARS-CoV-2 у світі, станом на 27.07.2025

Наразі BOO3 розглядає один варіант, що викликає занепокоєння (VOI) - JN.1 (Jenny), а також 6 варіантів під моніторингом (VUM), а саме LP.8.1, NB.1.8.1 (Nimbus), XFG (Stratus), XEC, KP.3.1.1 та KP.3. Протягом моніторингового періоду найпоширенішим варіантом (54%) був XFG (Stratus), збільшення порівняно з минулим тижнем (34%). Варіант NB.1.8.1 (Nimbus) виявлено у 30% поданих послідовностей, що нижче показника минулого тижня (34%). Протягом моніторингового періоду всі інші варіанти демонстрували тенденцію до зниження або стабільності. Наявні дані свідчать, що варіанти XFG та NB.1.8.1 не становлять додаткових ризиків для громадського здоров'я порівняно з іншими наразі циркулюючими варіантами SARS-CoV-2.

Оцінка BOO3

BOO3 продовжує моніторити еволюцію варіантів SARS-CoV-2 та проводити оцінку ризиків для визначених варіантів VOI та VUM за підтримки Технічної консультативної групи з еволюції вірусу (TAG-VE). Оцінка нині домінуючого LP.8.1, та нещодавно визначеного NB.1.8.1, свідчить про відсутність підвищеного ризику для громадського здоров'я, який становлять ці варіанти, порівняно з іншими циркулюючими варіантами: <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2025-DON572>

Щоб забезпечити надійну оцінку та управління ризиками COVID-19, BOO3 повторює свої рекомендації країнам щодо продовження моніторингу та звітування про активність SARS-CoV-2, вплив COVID-19 на громадське здоров'я та систему охорони здоров'я.

ECDC/BOO3 рекомендують здійснювати цілорічний епідеміологічний нагляд за респіраторними вірусами, зокрема за SARS-CoV-2.

Рекомендації BOO3

Після закінчення терміну дії останнього Глобального стратегічного плану готовності та реагування (SPRP) на 2023-2025 роки BOO3 опублікувала стратегічний та оперативний план високого рівня щодо управління загрозами коронавірусної хвороби, що мають значення для громадського здоров'я: <https://www.who.int/publications/m/item/strategic-and-operational-plan-for-coronavirus-disease-threat-management-at-a-glance>.

У грудні 2024 року BOO3 опублікувала оновлений пакет документів, розроблених для того, щоб допомогти країнам сформулювати політику, засновану на доказах, для боротьби з передачею SARS-CoV-2, особливо серед груп високого ризику та вразливих груп населення, а також для зниження захворюваності, смертності та довгострокових наслідків COVID-19: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-policy-briefs>

BOO3 нагадує, що Постійні рекомендації Міжнародних медико-санітарних правил (ММСП) щодо COVID-19, ухвалені у травні 2023 року, залишаються чинними до 30 квітня 2026 року: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA78/A78_INF7-en.pdf

Відстеження варіантів BOO3 з оцінкою ризику для циркулюючих VOI та VUM: <https://www.who.int/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants>

Усі технічні консультації щодо спалаху COVID-19 — на веб-сайті BOO3: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

Оновлення про спалах серед людей інфекції, спричиненої вірусом віспи мавп (тroph), у світі

14 серпня 2024 року відбулося 1-ше засідання Комітету ВООЗ із ММСР (2005) внаслідок появи нового штаму вірусу та швидкого його поширення в Демократичній Республіці Конго (ДРК) і дедалі більшій кількості країн Африки. Вдруге за два роки спалах трох оголошено надзвичайною ситуацією міжнародного значення для громадського здоров'я.

5 червня 2025 року відбулося 4-те засідання Комітету ВООЗ із ММСР (2005) щодо зростання трох у 2024 році, на якому визначено, що подія продовжує становити надзвичайну ситуацію міжнародного значення для громадського здоров'я: [https://www.who.int/news/item/09-06-2025-fourth-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-upsurge-of-mpox-2024-temporary-recommendations](https://www.who.int/news/item/09-06-2025-fourth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-upsurge-of-mpox-2024-temporary-recommendations). На 4 вересня 2025 року скликане 5-те засідання Комітету ВООЗ із ММСР (2005) щодо зростання трох.

31 січня 2022 року ВООЗ повідомлено про 158 425 підтверджених і 399 летальних випадків трох у людей (спричинених вірусом віспи мавп класи I та II), зі 138 країн і територій у шести регіонах ВООЗ (Африка, Америка, Східне Середземномор'я, Південно-Східна Азія, Європа і Західна частина Тихого океану). ВООЗ щотижня оновлює глобальні епідеміологічні дані: https://worldhealthorg.shinyapps.io/mpx_global/.

Тенденції неоднозначні: у деяких країнах та регіонах, найбільш уражених вірусом віспи мавп класи Ib, спостерігається зниження кількості випадків. В інших країнах реєструються нові спалахи,

оскільки вірус вражає країни, де раніше не було зареєстровано випадків: <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing---7-august-2025>

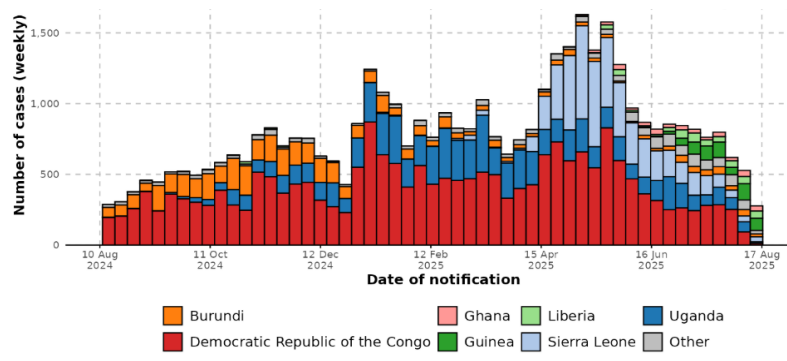
Станом на 31 липня 2025 року загалом 24 країни за межами Африки повідомили про 699 нових підтверджених випадків захворювання, зокрема 4 летальні.

Починаючи з січня 2022 року та станом на 31 липня 2025 року, детальні дані про випадки за межами Африки були зареєстровані для 103 363 випадки, що становить 65,2% усіх випадків, зареєстрованих за цей період.

За межами Африки більшість випадків трох зареєстровано серед дорослих осіб: 99% випадків припадає на людей віком від 18 років і старше. Серед випадків із зазначеною статтю 97% становлять чоловіки. Із тих, хто надавав інформацію про сексуальну поведінку, 89% ідентифікували себе як чоловіки, які мають секс з чоловіками (ЧСЧ). Найпоширенішим шляхом передачі інфекції за межами Африки залишається статевий контакт, який становить 88% від загальної кількості випадків з відомим шляхом передачі.

У країнах Африки наразі спостерігається поширення вірусу віспи мавп класи IIb— саме цього варіанту, який був причиною глобального спалаху.

За останні 12 місяців країнами, що продовжують повідомляти про найбільшу кількість випадків трох, спричинених вірусом віспи мавп класи Ib серед населення, є Демократична Республіка Конго (21 910), Уганда (7 869) та Сьєрра-Леоне (5 149); що свідчить про активну циркуляцію вірусу в регіонах.



З 1 січня 2022 року у 31 країна Африки зареєстровано 51 225 лабораторно підтверджених випадків (210 летальних). За останні дванадцять місяців, станом на 17 серпня 2025 року, 28 країн повідомили про 42 538 підтверджених випадків, зокрема 161 летальний. Двадцять країн Африки повідомила про постійну активну передачу вірусу віспи мавп класу Ib протягом останніх шести тижнів

Нещодавня загальна тенденція до зниження кількості підтверджених випадків у країнах Африки зумовлена зменшенням захворюваності у Сьєрра-Леоне, Демократичній Республіці Конго, а також певними затримками у звітності. Разом з тим, у Демократичній Республіці Конго продовжують спостерігатися проблеми з доступом до тестування.

Випадки трох, пов'язані з подорожами і спричинені вірусом класу Ib, були виявлені у 20 країнах за межами Африки у наступних регіонах ВООЗ: Американський (США, Канада, Бразилія); Європейський (Швеція, Швейцарія, Туреччина, Бельгія, Франція, Німеччина, Італія, Ірландія та Велика Британія, зокрема крім Швеції та Швейцарії, у 4 інших країнах відбулася вторинна передача вірусу); Південно-Східної Азії (Індія, Таїланд), Західної частини Тихого океану (Австралія, Китай, де відбулася вторинна передача вірусу), Східного Середземномор'я (Катар, Оман, Пакистан, ОАЕ).

Загалом, всі завезені випадки трох були підтверджені серед дорослих осіб, які подорожували під час інкубаційного періоду або вже мали ранні симптоми. Діагноз часто встановлювався після прибуття до країни. У більшості випадків повідомлялось про статеві контакти під час подорожей із особами, які були відомими або підозрюваними носіями трох.

Випадки трох, пов'язані з подорожами і спричинені вірусом класу Ia, були виявлені у 3 країнах за межами Африки: Китай, Ірландія та Туреччина.

Заходи з вакцинації проти трох розпочато у восьми країнах (Центральноафриканська Республіка, Демократична Республіка Конго, Ліберія, Нігерія, Руанда, Сьєрра-Леоне, Південно-Африканська Республіка, Уганда) із застосуванням вакцини MVA-BN, здебільшого за стратегією одноразової дози для груп високого ризику. Введено понад 869 000 доз, з них понад 69% — у ДР Конго. Інші країни, які нещодавно повідомили про випадки трох, розробляють національні плани вакцинації. Потрібне фінансування для розширення доступу до додаткових доз вакцини.

Оцінка ВООЗ

ВООЗ провела останню глобальну оцінку ризику трох у червні 2025 року. На основі наявної інформації ризик оцінюється таким чином:

Класи вірусу віспи мавп	Постраждалі території/населення	Рівень ризику
Ib	переважно вражає неендемичні райони Демократичної Республіки Конго та сусідніх країнах	високий
Ia	переважно вражає ендемічні райони Демократичної Республіки Конго	помірний
II	спостерігається в Нігерії та ендемічних країнах Західної та Центральної Африки	помірний
IIb	пов'язаний із глобальною епідемією, вперше задокументованою у 2022 році	помірний

Незалежно від класу вірусу деякі випадки, пов'язані з подорожами, можуть бути не виявлені, не підтверджені або не повідомлені, що збільшує ризик невиявленої місцевої передачі.

Рекомендації ВООЗ

17 квітня 2025 року ВООЗ оновило Глобальний стратегічний план готовності та реагування (SPRP) на трох. SPRP наголошує на важливості епіднагляду, досліджень, рівноправного доступу до медичних заходів протидії та розширення можливостей громад для реагування на спалах:

<https://www.who.int/publications/m/item/mpox-global-strategic-preparedness-and-response-plan-april-2025>

20 серпня 2025 року Генеральний директор ВООЗ продовжив дію Постійних рекомендацій: [https://www.who.int/news/item/19-08-2024-first-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-upsurge-of-mpox-2024](https://www.who.int/news/item/19-08-2024-first-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-upsurge-of-mpox-2024)

9 грудня 2024 року ВООЗ опублікувала збірку технічних рекомендацій про заходи реагування спільноти на тпрох. Цей короткий документ стосується постраждалих країн, а також тих, хто перебуває на відповідних етапах готовності: <https://www.who.int/publications/i/item/B09182>.

Інструмент оцінки ризику для виявлення та управління медичними працівниками та працівниками сфери догляду з потенційним професійним впливом вірусу віспи мавп: <https://www.who.int/publications/m/item/risk-assessment-health-workers-mpox>

Звіт про ситуацію зі спалахом тпрох у багатьох країнах містить оновлену інформацію: <https://www.who.int/publications/m/item/multi-country-outbreak-of-mpox--external-situation-report--56---31-july-2025>

Глобальна клінічна платформа ВООЗ щодо тпрох: <https://www.who.int/tools/globalclinicalplatform/monkeypox>

Набір інструментів із заходів реагування з приводу спалаху тпрох оновлено у лютому 2025 року: <https://www.who.int/emergencies/outbreak-toolkit/disease-outbreak-toolboxes/mpoxoutbreaktoolbox>

ІНФОРМАЦІЯ ЗА ДАНИМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ЕПІДНАГЛЯДУ (TESSy)

1

Про спалах гарячки Чикунгунья в Китайській Народній Республіці

17 серпня 2025 року Центр контролю та профілактики захворювань провінції Гуандун повідомив про 830 нових випадків гарячки Чикунгунья у період з 10 серпня 2025 року по 16 серпня 2025 року: https://cdcp.gd.gov.cn/ywdt/zdzt/yfjkkyl/yqxx/content/post_4759651.html

З початку спалаху у липні 2025 року і станом на 16 серпня 2025 року в провінції Гуандун було зареєстровано 9 933 випадки гарячки Чикунгунья. Більшість із них припадає на місто Фошань, хоча випадки також реєструвалися в інших містах, зокрема у Гуанчжоу, Чжуншані та Дунгуані. З 29 липня 2025 року у місті Фошань спостерігається тенденція до зниження кількості нових зареєстрованих випадків.

За межами провінції Гуандун, за повідомленнями ЗМІ з посиланням на органи охорони здоров'я, у Спеціальному адміністративному районі Макао було зафіксовано два випадки гарячки Чикунгунья.

Поточні заходи, вжиті урядом Китаю, зосереджені на боротьбі з переносниками інфекції — комарами, і включають очищення басейнів та інших джерел стоячої води, широке використання інсектицидів, дезінсекційні заходи з використанням дронів, інформаційно-просвітницькі кампанії щодо ризиків та профілактики зараження.

Оцінка ECDC

Хвороба, спричинена вірусом Чикунгунья, наразі не класифікується як хвороба, що підлягає обов'язковому повідомленню в Китаї. Водночас відомо, що *Aedes albopictus* та *Aedes aegypti* — визнані компетентні переносники вірусу Чикунгунья — присутні в провінції Гуандун.

У липні–серпні 2024 року понад 60 000 мандрівників прибули до ЄС/ЄЕЗ із цього регіону, а кількість подорожей зросла на 13% у червні 2025 року.

Китайські органи охорони здоров'я

Втім, завезення вірусу може спричинити обмежену місцеву передачу в ЄС/ЄЕЗ через наявність комарів-переносників.

Органи охорони здоров'я Китаю вживають заходів зі зменшення популяції комарів, тому ризик зараження для мандрівників оцінюється як низький, а клінічні прояви зазвичай легкі, тому загальний вплив оцінюється як низький.

Втім, завезення вірусу може спричинити обмежену місцеву передачу в ЄС/ЄЕЗ через наявність комарів-переносників.

Актуальна оцінка ризику щодо вірусу Чикунгунья для материкової частини ЄС/ЄЕЗ: <https://www.ecdc.europa.eu/en/chikungunya/surveillance-and-updates/risk-assessment>

Щотижневі звіти щодо випадків, спричинених вірусом Чикунгунья в країнах ЄС/ЄЕЗ: <https://www.ecdc.europa.eu/en/chikungunya-virus-disease/surveillance-and-updates/seasonal-surveillance>

ECDC закликає повідомляти про всі завезені випадки вірусу Чикунгунья з Китаю. Мандрівникам рекомендується захищатися від укусів комарів (репеленти, одяг з довгими рукавами, сітки, кондиціонер) протягом усього дня. Після повернення до ЄС/ЄЕЗ заходів слід дотримуватися ще три тижні, щоб запобігти місцевій передачі.

Сезонне спостереження за вірусом Чикунгунья у 2025 році

Станом на 20 серпня 2025 року дві країни Європи повідомили про випадки гарячки Чикунгунья: Італія (29) та Франція (156).

У 2025 році Франція повідомила про 156 місцевих випадків гарячки Чикунгунья у 27 адміністративних округах. Порівняно з попереднім тижнем кількість кластерів зросла на сорок п'ять. Двадцять кластерів класифікуються як активні.

Цього тижня Італія повідомила про 22 нові випадки, що збільшує загальну кількість випадків у чотирьох кластерах (наразі є активними) до 29.

Отримати додаткову інформацію про випадки захворювання можна у звіті ECDC щодо сезонного нагляду за гарячкою Чикунгунья: <https://chik-weekly.ecdc.europa.eu/>

З початку 2025 року у світі зареєстровано близько 317 000 випадків гарячки Чикунгунья (135 летальних) у 16 країнах/територіях. У Америці найбільше випадків зафіксовано в Бразилії, Болівії, Аргентині та Перу. В Азії – понад 40 000 у Індії, Шрі-Ланці, Пакистані та Китаї. В Африці випадки виявлені на Маврикії, у Сенегалі та Кенії, а також імпортовані до ЄС з Мадагаскару та Сейшелів. У Європі автохтонні випадки зареєстровані у Франції та Італії; на Реюньйоні – понад 54 500, на Майотті – 1 201, де з травня триває епідемія.

Оцінка ECDC

У поточному сезоні перші випадки з симптомами вже було виявлено наприкінці травня — раніше, ніж у попередні роки (зазвичай липень–серпень), що може бути пов'язано з високою кількістю завезених випадків.

Оцінка ризику інфікування вірусом Чикунгунья для материкової частини ЄС/ЄЕЗ: <https://www.ecdc.europa.eu/en/chikungunya/surveillance-and-updates/risk-assessment>

Сезонне спостереження за вірусом денге у 2025 році

З початку 2025 року та станом на 20 серпня 2025 року три країни Європи повідомили про випадки гарячки денге: Італія (4), Португалія (2) та Франція (11).

Цього тижня не було повідомлень про нові випадки гарячки денге у країнах Європи.

З початку 2025 року у світі зареєстровано понад 4 млн випадків денге (понад 2 500 летальних) у більш ніж 100 країнах усіх регіонів ВООЗ.

У ЄС/ЄЕЗ автохтонні випадки зафіксовані в Італії та Франції, а також у віддалених регіонах: на Мадейрі (2 випадки), Гваделупі (епідемія, серотип DENV-3), Мартиніці (спорадичні випадки), Сен-Мартені та Сен-Бартелемі (низька циркуляція), Французькій Гвіані (246 випадків, серотип DENV-2), Майотті (30 випадків, стабільна ситуація) та Реюньйоні (44 випадки, останній – у квітні).

У Америці станом на липень 2025 року зафіксовано понад 3,5 млн випадків, більшість – у Бразилії, Болівії, Аргентині та Перу; після весняного піку триває спад, але рівень вищий за середньорічний.

У Південно-Східній Азії спостерігається зростання випадків, особливо у Бангладеш та Індії (зниження лише у Кералі й Карнатаці); вірус денге також поширений у Таїланді, Шрі-Ланці, Непалі та на Мальдівах. У В'єтнамі, Лаосі та Сінгапурі кількість випадків нижча, ніж торік, тоді як у Китаї – значно зросла.

У Східному Середземномор'ї зростання зафіксовано в Афганістані (понад 590 випадків).

В Африці — понад 9 800 випадків (20 летальних), найбільше в Буркіна-Фасо, Сенегалі, Нігерії та Судані.

Оцінка ECDC:

Поточну оцінку ризику гарячки денге для материкової частини ЄС/ЄЕЗ можна знайти на веб-сайті ECDC: <https://www.ecdc.europa.eu/en/dengue/surveillance-and-updates/risk-assessment>

Сезонний епіднагляд за вірусом Західного Нілу (початок із 23 тижня)

Сезонне спостереження за циркуляцією вірусу Західного Нілу (WNV) у ЄС/ЄЕЗ розпочинається із 23 тижня кожного року. З початку сезону епіднагляду 2025 року та станом на 20 серпня 2025 року

дев'ять країн Європи повідомили про 250 випадків інфікування людей вірусом Західного Нілу (зокрема 10 летальних): Італія(168), Греція (46), Сербія (15), Франція(8), Румунія (6), Албанія (3), Угорщина (2), Болгарія (1) та Іспанія (1).

Кількість випадків трохи перевищує середній рівень за десятиліття (163), але значно нижча, ніж у 2018 та 2024 роках (>380 випадків).

Характерні риси цього року: високий рівень госпіталізації (100% випадків), летальність 7% (проти 11% у попередньому десятилітті), неврологічні прояви у 56% (раніше – 66%). Більшість випадків серед чоловіків 65+.

Зареєстровано 16 спалахів серед коней (Італія, Греція, Німеччина, Угорщина, Іспанія) та 20 спалахів серед птахів (Італія, Австрія). Найчастіше хворіли сороки, боривітри, ворони, чайки та голуби.

Оцінка ECDC:

У країнах Європи передача вірусу Західного Нілу зазвичай відбувається з середини червня до середини листопада, коли активність комарів є найвищою.

Відсутність зареєстрованих випадків серед людей у Європі у червні 2025 року разом зі значно меншою кількістю спалахів серед птахів та коней порівняно з 2024 роком свідчить про нижчий рівень циркуляції вірусу в навколишньому середовищі протягом сезону передачі у 2025 році. Природні коливання поширеності вірусу залежать як від рівня імунітету у популяціях птахів та/або коней, так і від екологічних умов. Очікується, що випадки захворювання серед людей можуть виникнути протягом найближчих тижнів.

Гарячка Західного Нілу підлягає реєстрації на рівні ЄС, про випадки слід повідомляти органи охорони здоров'я через Європейську систему епіднагляду (TESSy) відповідно до визначення випадку: <https://www.ecdc.europa.eu/en/west-nile-fever/facts>

Щотижневі оновлення щодо сезону передачі вірусу Західного Нілу 2025 році: <https://www.ecdc.europa.eu/en/west-nile-fever/surveillance-and-disease-data/disease-data-ecdc>

ECDC щомісяця надає розширений аналіз епідситуації з гарячки Західного Нілу, зокрема дані про кількість зареєстрованих випадків інфікування людей та спалахів гарячки Західного Нілу серед

однокопитних і птахів, отримані через Інформаційну систему про хвороби тварин (ADIS) Європейської комісії, та оцінку ситуації: <https://www.ecdc.europa.eu/en/infectious-disease-topics/west-nile-virus-infection/surveillance-and-disease-data/monthly-updates>

Сезонний епіднагляд за вірусом Крим-Конго геморагічної гарячки

Станом на 20 серпня 2025 року дві країни в Європі повідомили про випадки Крим-Конго геморагічної гарячки (ККГГ): Греція (2) та Іспанія (3).

Цього тижня не було повідомлень про нові випадки Крим-Конго геморагічної гарячки.

Випадки в Греції, що сталися в регіоні Фессалії, є несподіваними, оскільки в цьому регіоні та сусідніх регіонах раніше не реєструвалися випадки Крим-Конго геморагічної гарячки, не повідомлялось про циркуляцію вірусу ККГГ у тварин.

Випадки в Іспанії не є несподіваними, оскільки відомо, що вірус ККГГ циркулює серед тварин у провінції Саламанка, в автономній спільноті Кастилія і Леон, а випадки Крим-Конго геморагічної гарячки у людей раніше реєструвалися в цьому регіоні.

Оцінка ECDC:

З 2016 року по 2024 рік в Іспанії було зареєстровано 16 автохтонних випадків Крим-Конго геморагічної гарячки з початком захворювання квітень - серпень. Більшість випадків зареєстровано у провінції Саламанка, 50% випадків після укусу кліщів. У цій місцевості наявні кліщі виду *Hyalomma marginatum*, основний переносник цієї хвороби, а дослідження, проведені на диких і домашніх тваринах, показали серопревалентність вірусу вище 70%.

У Греції це перші випадки з 2008 року, коли було зареєстровано єдиний місцевий випадок у регіоні Фракія (що межує з Болгарією). Ця подія не була несподіваною, оскільки відомо, що вірус Крим-Конго геморагічної гарячки циркулює серед тварин у цьому регіоні.

Хоча ризик зараження для населення в районах, де вірус циркулює є низьким; ризик для професійних груп (полювання, лісові роботи, піші прогулянки, спостереження за тваринами) - різко зростає. Для зменшення ризику зараження вірусом Кримської-Конго геморагічної гарячки, а також іншими захворюваннями, що передаються кліщами, усім особам, які можуть потенційно зазнати впливу кліщів, рекомендується використовувати засоби індивідуального захисту від укусів кліщів: <https://www.ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/prevention-and-control/protective-measures-ticks>

Кліщі виду *Hyalomma spp.* вважаються основними переносниками вірусу Кримської-Конго геморагічної гарячки, кліщі виду *Hyalomma marginatum* широко поширені в південній та східній Європі. Ще одним переносником є кліщі виду *Hyalomma lusitanicum*, які присутні в деяких частинах південної Європи.

У 2024 році ВООЗ видала оперативні рекомендації з профілактики та контролю за вірусом Крим-Конго геморагічної гарячки у медичних закладах: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240093188>

ECDC стежить за циркуляцією вірусу Крим-Конго геморагічної гарячки, повідомлення про випадки в країнах ЄС/ЄЕЗ на веб-сайті ECDC: <https://www.ecdc.europa.eu/en/crimean-congo-haemorrhagic-fever/surveillance-and-updates/seasonal>

6

Про завезені випадки захворювання, спричиненого вірусом Оропуш, в країни ЄС/ЄЕЗ та Велику Британію у 2024/2025 роках

У 2025 році зареєстровано дев'ять завезених випадків захворювання, спричиненого вірусом Оропуш: Німеччина – 1 випадок (Домініка); Франція – 4 випадки (Бразилія, Колумбія, Пуерто-Рико); Австрія – 1 випадок (Колумбія); Велика Британія – 3 випадки (Бразилія).

У 2024 році підтверджено 44 випадки: Іспанія (23), Італія (8), Франція (7), Німеччина (3), Австрія (1), Швеція (1), Нідерланди (1). Більшість пов'язані з подорожами на Кубу (43), один – у Бразилію.

Хвороба, спричинена вірусом Оропуш, – це зоонозне захворювання. На сьогоднішній день спалахи були зареєстровані в кількох країнах Південної Америки, Центральної Америки та

Карибського басейну. Протягом 2024 року спалахи були зареєстровані в Бразилії, Болівії, Колумбії, Перу та нещодавно на Кубі. Вірус Оропуш переважно передається людям в результаті укусів інфікованих мошок, проте деякі види комарів також можуть поширювати вірус. Передається переважно через укуси інфікованих мошок (*Culicoides paraensis*), які в Європі відсутні. Доказів поширення вірусу європейськими комахами наразі немає.

Клінічні прояви – гостра гарячка, головний біль, нудота, біль у м'язах і суглобах; у поодиноких випадках – важкий перебіг. Летальність низька. Специфічних вакцин чи лікування немає. Передача від людини до людини не зареєстрована. Міністерство охорони здоров'я Бразилії повідомило про можливі випадки передачі вірусу Оропуш від матері до дитини під час вагітності.

Оцінка ECDC:

Для громадян ЄС/ЄЕЗ, які подорожують до ендемічних регіонів Південної та Центральної Америки, ризик зараження оцінюється як помірний.

Ймовірність зростає при відвідуванні муніципалітетів північних штатів Бразилії та регіону Амазонки, особливо за відсутності заходів особистого захисту.

У країнах ЄС/ЄЕЗ ризик місцевого поширення дуже низький, оскільки відсутні відповідні переносники та не зафіксовано вторинної передачі.

У більшості випадків прогноз одужання сприятливий, загальний вплив оцінюється як низький.

Нові дані свідчать, що інфекція у вагітних може призводити до викиднів, аномалій розвитку та деформацій плода. Ризик для вагітних жінок вищий, ніж для населення загалом.

Заходи індивідуального захисту для зниження ризику укусів включають використання

репелентів відповідно до інструкцій, носіння одягу з довгими рукавами та штанами, використання оброблених інсектицидами дрібносіткових москітних сіток під час відпочинку, перебування у приміщеннях із кондиціонуванням або захисними сітками на дверях і вікнах.

Необхідне підвищення настороженості серед лікарів щодо мандрівників, які повертаються з регіонів із передачею OROV.

Лабораторне тестування рекомендується у випадках, коли результати на інші арбовірусні інфекції є негативними.

Вагітним жінкам перед поїздками до ендемічних регіонів слід надати повну інформацію про ризику та заходи профілактики.

Рекомендації щодо подорожей можуть базуватися на аналогічних підходах, як і для вірусу Зіка.

Нові випадки мають повідомлятися через Epipulse для постійного моніторингу ситуації.

Посилання на рекомендації US CDC, зокрема із інформацією для вагітних жінок: <https://www.cdc.gov/han/2024/han00515.html>

Джерело: [European Centre for Disease Prevention and Control \(ECDC\)](https://www.ecdc.europa.eu/en/our-work/publications-and-reports/2024/01/20240101-01).

Стосовно подальшого розповсюдження, перекладу або копії змісту звертайтеся за адресою: info@phc.org